【引文格式】杨进,王倩,李正胜,等. 基于数据挖掘探究袁金声治疗失眠用药规律[J]. 中国中医药图书情报杂志,2025,49(3):15-20.

• 信息技术与中医药 •

基于数据挖掘探究袁金声治疗失眠用药规律

杨进[1]，王倩[1]，李正胜[1]，王文佳[2]，舒华[1]，胡蓉[3]，谢敏[1,2]，袁金声[1]

1. 贵州中医药大学第二附属医院，贵州 贵阳 550003；2. 贵州中医药大学，贵州 贵阳 550025；
3. 贵州省人民医院，贵州 贵阳 550001

摘要：目的　基于数据挖掘技术总结全国名中医袁金声治疗失眠用药规律。**方法**　收集袁金声2016年1月1日—2023年9月30日在贵州中医药大学第二附属医院名医堂治疗失眠处方，对处方药物用药频次、性味归经、功效类别等进行统计，采用关联规则分析、系统聚类分析、相关性分析对处方进行数据挖掘。**结果**　纳入处方433首，涉及中药207味，酸枣仁、黄连、首乌藤频次较高。药性以平、寒、微寒为主，药味以甘、苦、辛为主，归经以肝经、心经、脾经为主。药物功效以安神药、清热药、补虚药为主。共得到121条关联规则，发现核心处方酸枣仁-黄连-首乌藤-黄芩-茯神。系统聚类共聚为7类。相关性分析得到φ>0.6药对9组。**结论**　袁金声认为，失眠症患者阴阳失调，阳不入阴，治疗主张从“火热”论治，以清热泻火、宁心安神为法。

关键词：失眠；袁金声；R语言；数据挖掘；用药规律

中图分类号：R256.23；R2-03　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2095-5707(2025)03-0015-06

DOI：10.3969/j.issn.2095-5707.202401164　　**开放科学（资源服务）标识码（OSID）：**

Study on the Medication Law of Yuan Jinsheng in the Treatment of Insomnia Based on Data Mining

YANG Jin[1], WANG Qian[1], LI Zhengsheng[1], WANG Wenjia[2], SHU Hua[1], HU Rong[3], XIE Min[1,2], YUAN Jinsheng[1]

（1. The Second Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550003, China; 2. Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550025, China; 3. Guizhou Provincial People's Hospital, Guiyang 550001, China）

Abstract: Objective To summarize the medication law of Professor Yuan Jinsheng in the treatment of insomnia by data mining technology. **Methods** Professor Yuan's prescriptions for treating insomnia in Famous Doctor Hall of The Second Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine from January 1, 2016 to September 30, 2023 were collected. The frequency, properties, tastes, meridian tropism and efficacy categories of Chinese materia medica in the prescriptions were statistically analyzed. Association rule analysis, system clustering analysis, correlation analysis were used to conduct data mining on the prescriptions. **Results** A total of 433 prescriptions were included, involving 207 kinds of Chinese materia medica. Ziziphi Spinosae Semen, Coptidis Rhizoma and Polygonum Multiflorum Thunb had the highest frequency. The main properties were neutral, cold and slightly cold, the main tastes were sweet, bitter and pungent, and the meridian tropism was mainly liver, heart and spleen meridians. The efficacy classification of Chinese materia medica was mainly composed of sedative drugs, antipyretic drugs and tonic drugs. According to the analysis of association rules, 121 association rules were obtained. The core prescription was Ziziphi Spinosae Semen-Coptidis Rhizoma-Polygonum Multiflorum Thunb-Scutellariae

基金项目：全国名中医袁金声工作室建设项目（2022年）

通讯作者：谢敏，E-mail：421431047@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

Radix-Poria cum Radix. Seven types of TCM clusters were obtained by systematic cluster analysis. Correlation analysis showed that there were 9 groups of drug pairs with φ>0.6. **Conclusion** Professor Yuan Jinsheng thinks that insomnia patients are out of balance of yin and yang, and yang does not enter yin, and advocates that treating insomnia from "fiery heat", clearing away heat and purging fire and calming the heart and calming the nerves.

Keywords: insomnia; Yuan Jinsheng; R language; data mining; medication law

失眠指以频繁而持续的入睡困难和/或睡眠维持困难并致睡眠感不满意为特征的睡眠障碍，常伴有白天嗜睡、疲劳、头痛、身痛、情绪障碍等症状[1]，是最常见的睡眠问题之一。全球1/3成年人患有失眠[2]。失眠常合并其他疾病（如心脏代谢疾病）或精神障碍（如抑郁症），严重影响患者生活质量，对个体和社会造成沉重负担[3]。西医治疗本病以镇定安眠类药物为主，可在一定程度上改善患者失眠症状，但存在药物成瘾性、依赖性等问题。中医从调节阴阳、营卫、气血、五脏等方面治疗，具有独特优势。

袁金声教授为全国名中医，从医50余载，辨治失眠经验丰富。现基于数据挖掘技术总结袁老治疗失眠用药规律，为临床研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

纳入袁老2016年1月1日—2023年9月30日在贵州中医药大学第二附属医院名医堂收治的失眠病例。

1.2 处方筛选标准

纳入标准：①主要诊断为失眠，符合诊断标准[4]；②治疗结局为有效；③处方剂型为汤剂或颗粒剂，中药数量>5味；④多诊次病例，如就诊时间间隔>3个月，证型及用药明显改变者，计为不同处方；⑤处方基本信息、中西医诊断、药物组成、用法用量完整。

排除标准：①失眠为伴随症状；②严重肝肾功能不全或恶性肿瘤患者；③资料记录不全者；④合并服用西药、针灸、中成药者。

1.3 数据规范

由双人负责录入数据至Excel2019并交叉核对，确保数据准确性及完整性。录入资料包括患者姓名、年龄、性别、就诊时间、西医诊断、中医诊断、中医证型、处方用药及药物剂量等。中药名称、性味归经根据2020年版《中华人民共和国药典》[5]及《中药学》[6]进行规范，如"丹皮"规范为"牡丹皮"，二者均未记载药物，保留其原始名称，如"山枝仁"；因炮制功效、性味差别较大者予以保留，如"生地黄"与"熟地黄"等。药性保留原始药性，如"大热""大寒"等。药味保留原始药味，如"微苦""微辛"等。

1.4 数据分析

采用R4.2.3 itemFrequency函数对处方药物组成、性味归经、功效类别进行频次统计。基于Apriori算法、arules及arulesViz函数，设置支持度≥20%、置信度≥80%、提升度>1，对处方药物进行关联规则分析与可视化处理。其中，提升度>1认为有强关联规则，提升度越高表示前项中药与后项中药正相关性越大，应用价值越高。采用hclusts函数对频次>40药物进行系统聚类分析。采用Phi函数对频次>40药物进行相关性分析，使用pheatmap函数绘制热图。其中，Phi系数（φ）表示药物间关联程度，φ值越大，相关性越强。

2 结果

2.1 用药频次

本研究共纳入失眠病例379例，包含处方433首、中药207味，处方最多包含药物21味，最少包含药物6味，平均14味。药物总频次为5 981，以使用频次>100药物为高频药物，见表1。

表1 433首袁金声治疗失眠处方高频药物（频次>100）

序号	中药	频次	频率/%	序号	中药	频次	频率/%
1	酸枣仁	375	86.61	11	合欢皮	137	31.64
2	黄连	301	69.52	12	栀子	131	30.25
3	首乌藤	281	64.90	13	牡蛎	127	29.33
4	黄芩	242	55.89	14	龙骨	126	29.10
5	茯神	227	52.42	15	牡丹皮	123	28.41
6	当归	153	35.33	16	山药	122	28.18
7	龙齿	150	34.64	17	女贞子	114	26.33
8	丹参	148	34.18	18	木香	112	25.87
9	白芍	139	32.10	19	山萸肉	101	23.33
10	墨旱莲	138	31.87	20	枳实	101	23.33

2.2 性味归经

433首处方药物药性见表2，药性频次前3位为平、寒、微寒；药味见表3，药味频次前3位为甘、苦、辛；药物归经见表4，归经频次前3位为肝经、心经、脾经。

2.3 中药功效

中药功效分类见表5，频次前3位药物功效分别为安神药、清热药及补虚药，共占59.04%，其中，安神药以养心安神药为主，清热药以清热燥湿药为主，补虚药以补气药为主。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4　关联规则

获取关联规则121项，其中，2味药物组合32个、3味药物组合65个、4味药物组合22个、5味药物组合2个，不同组合支持度前10位关联规则见表6。关联规则支持度与置信度散点图见图1，关联规则平行坐标图见图2。设置支持度≥45%、置信度≥85%，得到由酸枣仁、黄连、首乌藤、黄芩、茯神组成的核心处方，见图3。

表2　433首袁金声治疗失眠处方药物药性分布

药性	频次	频率/%	药性	频次	频率/%
平	1 970	32.94	微温	363	6.07
寒	1 359	22.72	大寒	10	0.17
微寒	962	16.08	大热	10	0.17
温	907	15.16	热	3	0.05
凉	397	6.64			

表3　433首袁金声治疗失眠处方药物药味分布

药味	频次	频率/%	药味	频次	频率/%
甘	3 321	34.95	淡	366	3.85
苦	2 446	25.74	咸	307	3.23
辛	1 326	13.95	微苦	145	1.53
酸	1 086	11.43	微辛	31	0.33
涩	450	4.74	微甘	25	0.26

表4　433首袁金声治疗失眠处方药物归经分布

归经	频次	频率/%	归经	频次	频率/%
肝经	3 704	21.45	胆经	1 352	7.83
心经	2 847	16.49	大肠经	812	4.70
脾经	2 499	14.47	小肠经	288	1.67
肺经	2 067	11.97	三焦经	264	1.53
肾经	1 771	10.26	膀胱经	156	0.90
胃经	1 398	8.10	心包经	110	0.64

表5　433首袁金声治疗失眠处方药物功效分布

功效分类	频次	频率/%	药物示例（频次，前4位）
安神药	1 216	20.33	
养心安神药	861	14.40	酸枣仁（375）、首乌藤（281）、合欢皮（137）、合欢花（36）
重镇安神药	355	5.94	龙齿（150）、龙骨（132）、琥珀（55）、磁石（18）
清热药	1 169	19.55	
清热燥湿药	569	9.51	黄连（301）、黄芩（242）、黄柏（20）、白鲜皮（6）
清热凉血药	274	4.58	牡丹皮（150）、生地黄（84）、赤芍（36）、玄参（4）
清热泻火药	244	4.08	栀子（132）、知母（50）、夏枯草（22）、石膏（10）
清虚热药	48	0.80	地骨皮（35）、白薇（11）、山枝仁（2）
清热解毒药	34	0.57	蒲公英（16）、马齿苋（6）、山慈菇（4）、射干（3）
补虚药	1 146	19.16	
补气药	442	7.39	山药（122）、黄芪（80）、党参（76）、白术（50）
补血药	342	5.72	当归（153）、白芍（139）、何首乌（27）、熟地黄（18）
补阴药	341	5.70	墨旱莲（139）、女贞子（114、麦冬（36）、石斛（11）
补阳药	21	0.35	杜仲（7）、续断（7）、淫羊藿（5）、紫河车（2）
理气药	442	7.39	木香（112）、枳实（101）、陈皮（95）、枳壳（36）
活血化瘀药	397	6.64	
活血调经药	268	4.48	丹参（148）、怀牛膝（75）、鸡血藤（20）、川牛膝（12）
活血止痛药	125	2.09	川芎（73）、延胡索（30）、郁金（13）、马鞭草（5）
破血消癥药	4	0.07	莪术（3）、水蛭（1）
利水渗湿药	389	6.50	
利水消肿药	343	5.73	茯神（227）、茯苓（59）、薏苡仁（43）、泽泻（14）
利尿通淋药	35	0.59	车前子（12）、滑石（10）、通草（9）、绵萆薢（3）
利湿退黄药	11	0.18	虎杖（5）、茵陈（5）、金钱草（1）
平肝息风药	308	5.15	
平抑肝阳药	266	4.45	牡蛎（127）、珍珠母（98）、蒺藜（16）、石决明（15）
息风止痉药	42	0.70	钩藤（31）、天麻（6）、地龙（3）、僵蚕（2）
化痰止咳平喘药	209	3.49	
温化寒痰药	109	1.82	法半夏（80）、胆南星（27）、白前（27）
清化热痰药	67	1.12	竹茹（21）、瓜蒌皮（19）、桔梗（18）、前胡（5）
止咳平喘药	33	0.55	苦杏仁（27）、枇杷叶（4）、款冬花（2）

中国知网　https://www.cnki.net

表6　433首袁金声治疗失眠处方药物前10位关联规则（支持度≥20%、置信度≥80%、提升度>1）

类别	前项	后项	支持度/%	置信度/%	提升度	数量
2味药物组合	黄连	酸枣仁	64.20	92.36	1.07	278
	首乌藤	酸枣仁	63.28	97.51	1.13	274
	黄芩	酸枣仁	50.35	90.08	1.04	218
	茯神	酸枣仁	50.12	95.59	1.10	217
	黄芩	黄连	48.27	86.36	1.24	209
	龙齿	酸枣仁	34.18	98.67	1.14	148
	丹参	酸枣仁	32.79	95.95	1.11	142
	当归	酸枣仁	32.33	91.50	1.06	140
	合欢皮	酸枣仁	31.18	98.54	1.14	135
	墨旱莲	酸枣仁	29.33	92.03	1.06	127
3味药物组合	黄连, 首乌藤	酸枣仁	49.65	96.85	1.12	215
	黄连, 黄芩	酸枣仁	45.27	93.78	1.08	196
	黄芩, 酸枣仁	黄连	45.27	89.91	1.29	196
	茯神, 黄连	酸枣仁	39.95	97.74	1.13	173
	黄芩, 首乌藤	酸枣仁	37.64	97.60	1.13	163
	黄芩, 首乌藤	黄连	36.72	95.21	1.37	159
	茯神, 首乌藤	酸枣仁	35.80	98.73	1.14	155
	茯神, 黄芩	酸枣仁	31.64	97.86	1.13	137
	茯神, 首乌藤	黄连	30.02	82.80	1.19	130
	茯神, 黄芩	黄连	29.56	91.43	1.32	128
4味药物组合	黄连, 黄芩, 首乌藤	酸枣仁	35.80	97.48	1.13	155
	黄芩, 首乌藤, 酸枣仁	黄连	35.80	95.09	1.37	155
	茯神, 黄连, 首乌藤	酸枣仁	29.56	98.46	1.14	128
	茯神, 首乌藤, 酸枣仁	黄连	29.56	82.58	1.19	128
	茯神, 黄连, 黄芩	酸枣仁	29.10	98.44	1.14	126
	茯神, 黄芩, 酸枣仁	黄连	29.10	91.97	1.32	126
	黄连, 龙骨, 牡蛎	酸枣仁	22.86	98.02	1.13	99
	龙骨, 牡蛎, 酸枣仁	黄连	22.86	86.09	1.24	99
	黄连, 龙骨, 酸枣仁	牡蛎	22.86	96.12	3.28	99
	黄连, 牡蛎, 酸枣仁	龙骨	22.86	95.19	3.27	99
5味中药组合	茯神, 黄连, 黄芩, 首乌藤	酸枣仁	22.17	98.97	1.14	96
	茯神, 黄芩, 首乌藤, 酸枣仁	黄连	22.17	96.97	1.39	96

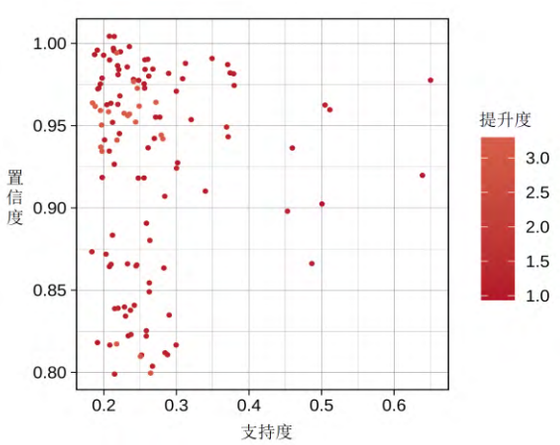


图1　433首袁金声治疗失眠处方药物关联规则支持度、置信度散点图

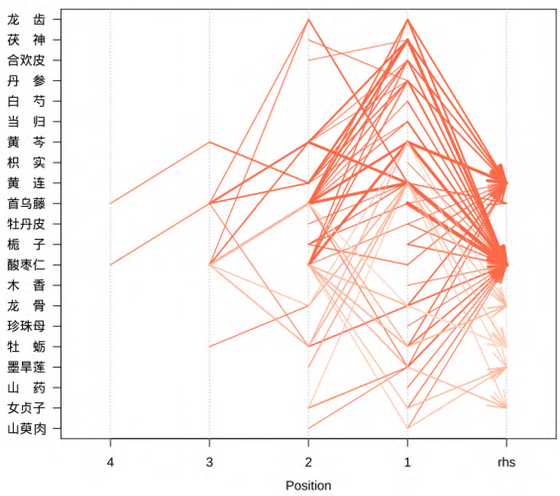
2.5　聚类分析

纳入频次>40的38味中药进行聚类分析，药物总频次为4 467，占74.69%，具有代表性。使用R语言hclust函数进行系统聚类分析，得到7个有效聚类，聚类网络见图4。7个聚类分别为：①山萸肉、墨旱莲、女贞子、菊花、牛膝、牡丹皮、生地黄；②龙齿、珍珠母、丹参、栀子、琥珀、川芎、知母；③龙骨、牡蛎；④合欢皮、茯神、黄芩、黄连、酸枣仁、首乌藤；⑤建曲、焦山楂、麦芽；⑥太子参、山药、木香、当归、白芍、白术、黄芪、党参；⑦茯苓、薏苡仁、枳实、陈皮、法半夏。

2.6　相关性分析

φ理论将计数情况映射至二联表，以卡方检验判定相关性的显著性，通过$\varphi = \mathrm{sqrt}(x^2/n)$计算。使用Phi函数计算频次>40的38味药物间φ值，药物相关性热图见图5。其中φ>0.6的药组有9对，分别为焦山楂-炒麦芽（0.96），炒麦芽-建曲（0.96），龙骨-牡蛎（0.94），墨旱莲-女贞子（0.84），墨旱莲-山萸肉（0.75），陈皮-法半夏（0.70），党参-黄芪（0.70），女贞子-山萸肉（0.66）。

中国知网　https://www.cnki.net



注：折线越粗，支持度越大；颜色越深，提升度越高

图2　433 首袁金声治疗失眠处方药物关联规则平行坐标

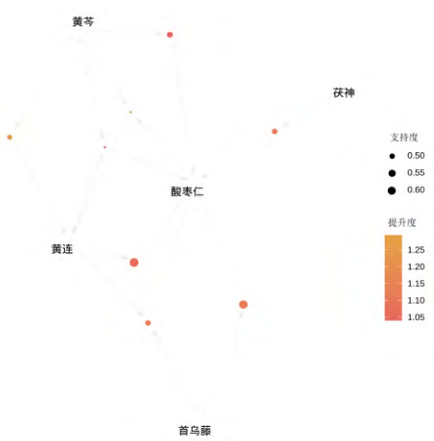


图3　433 首袁金声治疗失眠处方药物关联网络

（支持度≥45%、置信度≥85%）

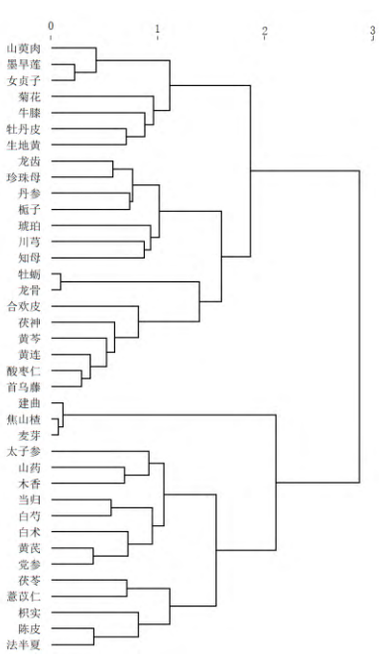


图4　433 首袁金声治疗失眠处方药物聚类网络（频次>40）

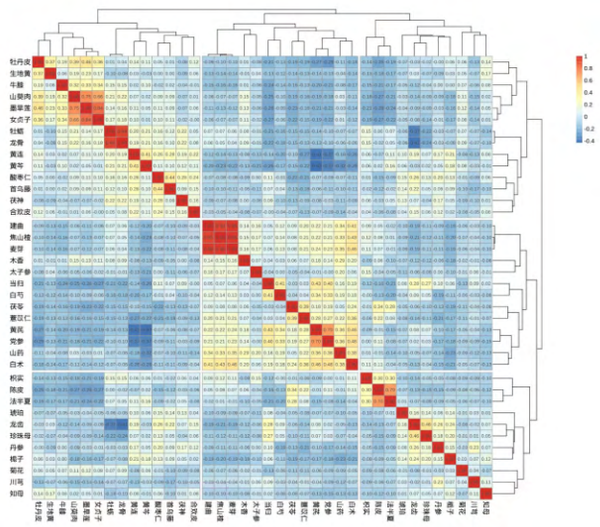


图5　433 首袁金声治疗失眠处方药物相关性分析热图（频次>40）

3　讨论

失眠可归属中医学“不寐”范畴。《灵枢·邪客》有“不得卧”“目不瞑”的论述，其病机为阳盛阴亏，治疗应补其不足、泻其有余。失眠有气虚、血虚、阴虚、阳虚、痰湿、瘀血等多种病因，《失眠症中医临床实践指南》[7]将该病分为9个证型，实证包括心火炽盛证、肝郁化火证、痰热内扰证、胃气不和证及瘀血内阻证，虚证包括阴虚火旺证、心脾两虚证、心胆气虚证及心肾不交证。袁老认为，失眠与患者年龄、性别、生活压力、遗传、个性特征、躯体疾病等有关，其病位主要在心，与肝、脾、肾相关，病机与火热之邪偏盛、机体气血阴阳失和有关。火热邪气又有实火与虚火之分。

分析发现，苦性、寒性药使用频次较高（第2位）；在频次前4位药物中，黄连、黄芩均为清热药；功效分析发现，清热药使用频次为19.55%。药物归经结果显示，肝经、心经使用频次较高。关联规则分析得出的核心方由酸枣仁、黄连、首乌藤、黄芩、茯神组成，均属于安神药及清热药。袁老认为，失眠症患者因喜食辛辣或情志抑郁或作息紊乱等导致的阳热亢盛为实火，尤以心火、肝火、痰火最为常见。临床诊疗时，袁老常用黄连黄芩泻心汤与栀子豉汤治疗心火炽盛者、龙胆泻肝汤治疗肝郁化火者、黄连温胆汤治疗痰火扰心者。

失眠症患者因年老久病或素体阴亏或调摄不慎等导致的阴液亏乏、阴不涵阳，阳气浮越为“虚火”，以心肾不交、肝肾阴虚常见。袁老辨治虚火失眠患者，重视滋补心阴、肝阴、真阴。因阴亏火旺导致心烦不得眠者，常用黄连阿胶汤合生地黄、麦冬、沙参加减；因肝阴虚致阳亢烦扰神魂，常用酸枣仁汤；因真阴不

中国知网　https://www.cnki.net

足致失眠常用血肉有情之品（如龟板、鳖甲等）大补真阴。袁老尤喜用酸枣仁，用药频次结果显示，酸枣仁使用频次最高（86.61%）。酸枣仁性平，味甘、酸，可养心补肝、宁心安神，用于虚烦不眠，惊悸多梦。对于心肾不交患者，心火与肾水相互克制是维持二脏正常生理功能的基础，心肾经络互联，精神互用，阳气互资，精血互化。袁老善用经方交泰丸与黄连阿胶汤治疗此证，其认为心火肾水不能上下相济、阴阳相交，则少阴热化，故用黄连、黄芩泻火，芍药补血，鸡子黄补心血，阿胶益肾精，诸药配伍使水火既济。又认为心虚无血养心，心神不能归潜入肾，症见入睡困难；肾虚不能藏纳心神，症见睡眠维持困难。故对入睡困难者，应重用补益心气之品；对睡眠不能维持者，应重用补益肾气之药。

袁老认为，失眠与情志不畅、脾胃不调关系密切。对情志不畅者，常加疏肝、安神的合欢皮或合欢花。研究发现，广泛性焦虑患者中91.66%有睡眠障碍，其心理状况对睡眠质量影响较大[8]。因此，在用药同时应注重调畅情志，保持乐观，适当运动，劳逸有度。对脾胃不调者，有虚实之分，虚指脾胃失和，运化失司，则气血乏源，心神失养；实指有形实邪（如痰浊、宿食、火热等）阻塞脾胃，胃不和则卧不安。脾胃是气血生化之源，气机升降之枢纽，脾胃和则阴阳平衡，出入有常。袁老调和脾胃主要从虚实2个方向进行。对于虚者，主张补虚和中，中气虚常用补中益气汤，年老气血亏虚常用归脾汤，胃阴不足常用益胃汤等；对于实者，主张祛实畅中，宿食积滞者常用保和丸，痰浊阻滞常用二陈汤等。袁老基于“治中焦如衡，非平不安”的原则，用药多以甘平为主，本研究四气五味结果显示平性与甘味使用频次最高。

袁老认为，临证应详细分析患者证型，动态辨治。本研究得到7个药物聚类：①山萸肉、墨旱莲、女贞子、菊花、牛膝、牡丹皮、生地黄，主要功效为滋补肝肾、清热凉血，适用于肝肾不足、阴虚发热者，如更年期失眠者；②龙齿、珍珠母、丹参、栀子、琥珀、川芎、知母，主要功效为活血清热、镇惊安神，适用于血瘀发热者；③龙骨、牡蛎，主要功效为重镇安神潜阳，适用于心悸不安者；龙骨、牡蛎是袁老常用药对，用以镇静安神。相关性分析结果显示，龙骨、牡蛎高度相关（φ=0.95）。龙骨性平，味甘、涩，可镇惊安神、平肝潜阳；牡蛎性微寒，味咸，可重镇安神、潜阳补阴。龙骨属阳，能潜上越之浮阳；牡蛎属阴，能摄下陷之沉阳。龙骨、牡蛎主要成分为钙，当人体血钙低时，神经肌肉兴奋性增加，容易出现失眠、心慌等症。研究表明，龙骨与牡蛎配伍，可增强镇静作用，使阴液得补，阳气得潜，心神得安[9]。④合欢皮、茯神、黄芩、黄连、酸枣仁、首乌藤，主要功效为清热泻火、宁心解郁安神，适用心火亢盛兼肝郁者；⑤建曲、焦山楂、麦芽，主要功效为消食化滞，适用食积纳差者；⑥太子参、山药、木香、当归、白芍、白术、黄芪、党参，主要功效为益气健脾补血，适用于气血两虚者；⑦茯苓、薏苡仁、枳实、陈皮、法半夏，主要功效为燥湿化痰，适用于痰浊阻滞者。由聚类结果可知，失眠发病与多种病理因素相关（痰、火、气、瘀、虚），其病程可侵犯多脏（心、肝、脾、肾）。袁老强调，各病理因素间相互夹杂，互为因果，临证需动态思辨。

综上所述，本文通过数据挖掘总结袁老辨治失眠用药规律，得到由酸枣仁、黄连、首乌藤、黄芩、茯神组成的核心方，体现袁老清热泻火、宁心安神为失眠治疗大法，为临床辨治失眠提供参考。

参考文献：

[1] 苏亮,陆峥.2017年中国失眠症诊断和治疗指南解读[J].世界临床药物,2018,39(4):217-222.

[2] Perlis M L,Pigeon W R,Grandner M A, et al. Why treat insomnia?[J]. Journal of Primary Care Community Health,2021,12:215013272110140.

[3] 刘帅,张斌.《中国失眠障碍诊断和治疗指南》解读[J].中国现代神经疾病杂志,2017,17(9):633-638.

[4] 中国睡眠研究会.中国失眠症诊断和治疗指南[J].中华医学杂志,2017,97(24):1844-1856.

[5] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[M].北京:中国医药科技出版社,2020.

[6] 钟赣生,杨柏灿.中药学(新世纪第五版)[M].北京:中国中医药出版社,2021.

[7] 中国中医科学院失眠症中医临床实践指南课题组.失眠症中医临床实践指南(WHO/WPO)[J].世界睡眠医学杂志,2016,3(1):8-25.

[8] 高旭芳,邹涛,朱祥路,等.广泛性焦虑患者治疗前睡眠质量与心理状况调查[J].贵阳医学院学报,2010,35(1):53-55.

[9] 江澄,林胜友.裘昌林运用对药治疗不寐经验[J].中华中医药杂志,2014,29(6):1893-1895.

（收稿日期：2024-01-31）
（修回日期：2024-04-20；编辑：宋源）

中国知网 https://www.cnki.net